

Asma na criança · crise e manutenção

Na criança, a crise asmática responde a SABA com espaçador/máscara e corticoide sistêmico precoce. Controle crônico evita idas à emergência — corticoides inalatórios são a base no persistente.

Espaçador > nebulização na maioria

Dica - Espaçador > nebulização na maioria

Dose adequada de salbutamol com espaçador é tão eficaz quanto nebulização na crise leve-moderada e reduz aerossolização — ponto clássico de prova.

Fluxo: gravidade !' broncodilatação seriada + corticoide !' alta com plano ou internação.

Crise asmática pediátrica

Avaliar -> SABA + corticoide -> decidir destino

Avaliar gravidade

fala / SatO₂ / esforço

SABA + corticoide

espaçador / EV se grave

Destino

alta planejada ou internar

Manutenção (ideia)

- CI (budesonida/beclometasona etc.) no persistente; associar LABA se preciso (idade/indicação)
- Educação: técnica inalatória, plano de crise, evitar gatilhos
- Comorbidades: rinite, refluxo, obesidade, tabagismo passivo
- Corticoide oral de manutenção só em casos refratários — não é rotina

Crise — intensificação

Gravidade | Conduta

Leve-moderada | SABA seriado + corticoide VO

Grave | O₂ , + SABA ± ipratrópio + corticoide; considerar MgSO₄ „

Ameaça à vida | UTI / via aérea; não sedar fora de suporte

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Lactente sibilante de 1ª crise não é 'asma confirmada'. Trate o broncoespasmo agudo, mas reserve o rótulo de asma para padrão recorrente + contexto atópico/idade.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

A classificação da crise asmática (leve/moderada/grave/parada iminente) define salbutamol, corticoide e necessidade de suporte avançado.

Fale em frases? Tiragem? SatO₂ ,? Pico de fluxo? Isso estratifica a crise.

Crise asmática - gravidade

Leve / moderada / grave

Leve

Fala frases
Sibilos leves
SatO2 boa

SABA +/- corticoide

Moderada

Fala frases curtas
Tiragem
SatO2 limiar

SABA seriado + corticoide

Grave

Fala palavras
Silencio toracico
SatO2 baixa

Emergencia / UTI

Quanto mais itens 'vermelhos', mais agressiva a conduta e a observação.

Sinais de gravidade

Checklist mental da crise

Dificuldade para falar	+
Tiragem / uso de musculo acessorio	+
SatO2 < 92-94%	+
PFE muito reduzido	+
Cianose / confusao	++
Silencio toracico	++

Parada iminente: silencio + bradicardia + confusao

Conduta da crise (prova)

Passo | Conduta

- 1º | Salbutamol inalatório com espaçador (ou neb) seriado
 - 2º | Corticóide sistêmico precoce (prednisolona/dexametasona)
- O, | Se hipoxemia — alvo usual ~94–98%
- Refratária | Sulfato de magnésio IV; avaliar UTI/VNI

Manutenção (resumo)

- Educação + técnica inalatória + plano de ação
- Corticóide inalatório se crises recorrentes / controle ruim
- Evitar gatilhos; tratar rinite/DRGE quando relevantes

Armadilha

Atencao - Armadilha

Silêncio torácico não é melhora — é gravidade extrema. Lactente sibilante no 1º episódio de inverno: pense bronquiolite antes de 'asma'.

